



QCM Sujet 5 : Arrêt cardio-circulatoire

Cycle de préparation de l'ECN
2025/2026

Dr Kamilia Chtara

La séquence de RCP lors d'une FV est la suivante :

- A. choc électrique externe – 1 mg adrénaline – 2 g sulfate de Mg^{2+}
- B. 30 compressions – 2 insufflations – 1 mg d'adrénaline
- C. choc électrique externe – 2 minutes de compressions thoraciques avec insufflations – réévaluation du rythme au bout de 2 minutes
- D. 2 minutes de compressions thoraciques avec insufflations – choc électrique externe – réévaluation du rythme au bout de 2 minutes
- E. 1 mg d'adrénaline – 2 minutes de compressions thoraciques avec insufflations – réévaluation du rythme au bout de 2 minutes

La séquence de réanimation cardiopulmonaire chez un adulte se présentant en arrêt circulatoire en extrahospitalier:

- A. 30 compressions – 2 insufflations – appel des secours
- B. appel des secours - 30 compressions – 2 insufflations
- C. 5 insufflations – 30 compressions – appel des secours
- D. appel des secours – 2 insufflations - 30 compressions
- E. 1 minute de réanimation cardiopulmonaire – appel des secours – reprise de la réanimation cardiopulmonaire

Au branchement du patient au moniteur, le rythme de l'arrêt est une asystolie, l'algorithme de la réanimation cardiopulmonaire avancée adéquat est le suivant :

- A. 30 compressions et 2 insufflations avec 1 mg adrénaline après 6 minutes de réanimation cardiopulmonaire
- B. défibrillation précoce puis réanimation cardiopulmonaire pendant 2 minutes puis 1 mg d'adrénaline
- C. reprendre les compressions thoraciques administrer 1 mg d'adrénaline immédiatement puis réanimation cardiopulmonaire pendant 2 minutes
- D. réanimation cardiopulmonaire pendant 2 minutes puis 1 mg d'adrénaline
- E. 300 mg d'amiodarone puis réanimation cardiopulmonaire pendant 2 minutes

Lors de la réanimation cardiopulmonaire avancée:

- A. La cordarone est administrée sur 1 heure
- B. La dose recommandée d'adrénaline est de 1mg/kg
- C. Les chocs électriques externes sont synchrones
- D. Les chocs électriques externes sont à la dose de 360 joule en mode monophasique
- E. L'évaluation du rythme se fait toutes les 2 minutes

Concernant l'activité électrique sans pouls

- A. L'adrénaline est administré dès le 1^{ier} cycle de réanimation
- B. Le choc hémorragique est une étiologie fréquente
- C. L'intubation est à envisager après retour du pouls
- D. Le choc électrique externe est indiqué immédiatement
- E. L'activité mécanique du cœur est absente

Les causes réversibles de l'arrêt cardiaque sont:

- A. Une hypocalcémie
- B. Une hypokaliémie
- C. Une hyperoxie
- D. Une hypoglycémie
- E. Une hyperthyroïdie

Lors de la réanimation d'un ACR

- A. 5 insufflations sont indiquées avant le MCE
- B. Les 30 compressions thoraciques sont suivies par 5 insufflations
- C. Le CEE est délivré avec le mode asynchrone
- D. L'adrénaline est administrée après le 3ème choc électrique externe
- E. Il faut sélectionner le maximum d'énergie lorsque le choc est indiqué

Au cours de l'arrêt cardio-circulatoire:

- A. Le premier témoin doit commencer le MCE
- B. Le rythme du MCE doit être de 100 à 120 battements/minute
- C. Une réanimation cardiopulmonaire (RCP) comporte 2 ventilations et 15 compressions thoraciques en alternance
- D. La RCP de base est le premier maillon de la chaîne de survie
- E. Le monitoring par un défibrillateur est primordial pour confirmer l'arrêt

Devant une asystolie

- A. 1 mg d'adrénaline est administré après 6 minutes de RCP
- B. Une défibrillation précoce est indiquée
- C. Le chlorure de Ca^{2+} est administré après 2 min des RCP
- D. Le bicarbonate de sodum est indiqué d'emblée
- E. Le MCE doit être le plus précocement possible

L'adrénaline est le traitement de choix de ACR car

- A. Elle a un effet inotrope positif
- B. Elle agit sur les récepteurs α et β adrénergiques
- C. Elle a un effet bathmotrope négatif
- D. Elle améliore le débit sanguin coronaire et cérébral
- E. Elle a un effet stabilisant de membrane

Cas clinique QCM

Un homme âgé de 30 ans admis aux urgences pour prise en charge d'un polytraumatisme.

A l'examen: il est agité, PA 70/40 mm Hg, FC à 160 battements/minute, FR: 35 cycles/minute avec des signes de lutttes respiratoires, SpO2 à 75 % à l'air ambiant, auscultation pulmonaire: diminution des murmures vésiculaires. Quelques minutes après, il présente un arrêt circulatoire avec une fibrillation ventriculaire au moniteur.

Le premier geste à faire :

- A. Une voie veineuse périphérique
- B. Un massage cardiaque externe
- C. Un choc électrique
- D. Une injection de cordarone
- E. Une injection d'adrénaline

Au bout de 2 minutes de RCP le patient est toujours en fibrillation ventriculaire, votre CAT durant le prochain cycle comporte:

- A. Un choc électrique externe
- B. Intubation ou mise en place de moyens supraglottique
- C. Un massage cardiaque externe
- D. Une injection de cordarone
- E. Une injection d'adrénaline

Après 2 minutes, le moniteur présente une activité électrique compatible avec la vie, le premier geste à faire est:

- A. Arrêter le massage cardiaque
- B. Vérifier le pouls
- C. Intuber le patient
- D. Commencer la réanimation post arrêt
- E. Administrer le cordarone pour préserver le rythme

L'anoxie post arrêt cardiaque entraine :

- A. Une accumulation intracellulaire de H^+
- B. Une libération des facteurs inducteurs de l'apoptose
- C. Une altération des mécanismes de défense contre les radicaux libres
- D. Une altération de la cohésion cellulaire
- E. Une augmentation de la synthèse de l'ATP

Quelle est la cause la plus fréquente de l'arrêt cardio-circulatoire ?

- A. Cause respiratoire
- B. Cause cardiaque
- C. Cause toxique
- D. Cause neurologique
- E. Cause septique

Les causes réversibles à rechercher devant un arrêt cardio-circulatoire sont:

- A. Hyperthermie
- B. Pneumothorax
- C. Hypokaliémie
- D. Hypoxie
- E. Hypovolémie

Les signes cliniques qui permettent de poser le diagnostic d'arrêt cardio-circulatoire sont:

- A. Coma
- B. Absence de pouls central
- C. Absence de respiration spontanée
- D. Mydriase bilatérale
- E. Cyanose

Concernant les compressions thoraciques:

- A. La profondeur des compressions est de 3 cm
- B. Le temps de la compression est supérieur au temps de la décompression
- C. Le rythme des compressions thoraciques est de 2 par seconde (100-120 battement/min)
- D. L'évaluation du rythme cardiaque se fait après 2 mn
- E. Elles ne doivent être commencées qu'après vérification du tracé électrocardiographique

La succession des maillons de la chaîne de survie est comme suit:

- 1- Réanimation cardiopulmonaire spécialisée
- 2- Réanimation cardiopulmonaire de base
- 3- Défibrillation
- 4- Alerte

- A. 2-3-1-4
- B. 4-2-1-3
- C. 4-2-3-1
- D. 2-1-4-3
- E. 4-3-2-1

Devant un patient en asystolie, le geste prioritaire est :

- A. L'intubation orotrachéale
- B. Les compressions thoraciques
- C. Le choc électrique externe
- D. L'administration de 1 mg d'adrénaline en IV
- E. La ventilation bouche à bouche

Concernant la défibrillation:

- A. Une électrode est appliquée en sous claviculaire droit et l'autre en sous axillaire gauche
- B. Sa précocité améliore le pronostic
- C. L'asystolie est parmi les indications à la défibrillation
- D. Après la défibrillation, l'évaluation du rythme au scope se fait après un cycle de 2 minutes de RCP
- E. Elle ne doit être utilisée que par un médecin

Les indications de la défibrillation dans l'arrêt cardiaque sont :

- A. Asystolie
- B. Fibrillation ventriculaire
- C. Dissociation électromécanique
- D. Tachycardie ventriculaire sans pouls
- E. La non récupération après 10 min

Le médicament de 1ère intention en cas de rythme non choquable :

- A. Noradrénaline
- B. Adrénaline
- C. Amiodarone
- D. Sulfate de magnésium
- E. Dobutamine

Concernant l'utilisation de l'adrénaline en cas d'arrêt cardiaque:

- A. Elle est indiquée en cas de dissociation électromécanique
- B. Elle est indiquée en association avec le 1er choc électrique externe en cas de tachycardie ventriculaire sans pouls
- C. Elle est indiquée en cas de rythme choquable après 3 chocs électriques externes
- D. Le rythme d'administration est de 1 mg toutes les 3-5 minutes
- E. Peut être administrée en intracardiaque en l'absence de voie veineuse

le soluté à utiliser après la mise en place de voie veineuse périphérique au cours d'un arrêt cardio circulatoire :

- A. Sérum glucosé 5%
- B. Sérum glucosé 10%
- C. Bicarbonate de sodium 4.2%
- D. Bicarbonate de sodium 8.4%
- E. Chlorure de sodium 0.9%

Concernant les compressions thoraciques :

- A. Le rapport (compression : ventilation) est de 30:2 pour un arrêt cardiaque chez l'adulte avant que les voies respiratoires ne soient sécurisées.
- B. Les compressions doivent être continues et les ventilations doivent être effectuées à un rythme de 15 insufflations par minute une fois que les voies respiratoires ont été sécurisées.
- C. La fréquence de compression doit être de 80 par minute.
- D. Un relâchement incomplet de la poitrine pendant la RCR peut réduire la perfusion coronarienne et cérébrale.
- E. on commence toujours par les insufflations

Pour éviter la fatigue il faut alterner les compressions thoraciques

- A. Environ toutes les 2 minutes
- B. Environ toutes les 3 minutes
- C. Environ toutes les 4 minutes
- D. Environ toutes les 5 minutes
- E. Environ toutes les 6 minutes

Le geste à réaliser immédiatement après avoir administré un choc est:

- A. Vérifier le rythme cardiaque
- B. Se préparer à administrer un deuxième choc
- C. Reprendre les compressions thoraciques
- D. Commencer la ventilation de secours
- E. Vérifier le pouls

Lors de la réanimation cardiopulmonaire avancée d'un arrêt cardiaque avec un rythme choquable :

- A. L'adrénaline doit être administrée dès qu'un accès veineux est obtenu
- B. On doit administrer 2mg d'adrénaline et 300mg d'amiodarone après le 3ème choc si le rythme choquable persiste
- C. On peut utiliser aussi bien l'amiodarone que le lidocaïne.
- D. Lors de choc, on doit appliquer les palettes sur le thorax : une au-dessous de la clavicule droite à cote du sternum et une sous axillaire gauche en basithoracique
- E. Il faut s'assurer de la sécurité et éloigner la source d'oxygène avant le choc

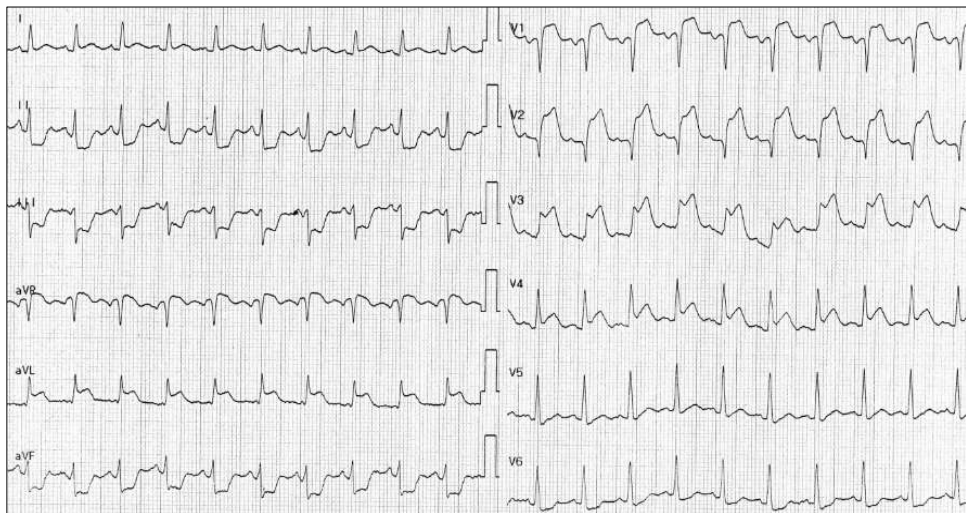
Pendant la réanimation cardiopulmonaire avancée chez l'adulte :

- A. L'adrénaline 5 mg est indiquée.
- B. La vasopressine est recommandée lorsque l'adrénaline n'est pas disponible.
- C. La lidocaïne peut être utilisée lorsque l'amiodarone n'est pas disponible.
- D. Si des thrombolytiques sont utilisés, poursuivez la RCP pendant 60 à 90 minutes.
- E. Une hypothermie thérapeutique est recommandée pour les survivants d'un arrêt cardiaque

Cas clinique-QCM

Un homme âgé de 70 ans, aux ATCD : tabagisme actif 40 PA, diabète type2 et HTA sous IEC, a consulté à la salle d'urgence médicale pour une douleur thoracique retro sternale de type brulure irradiant vers la mâchoire.

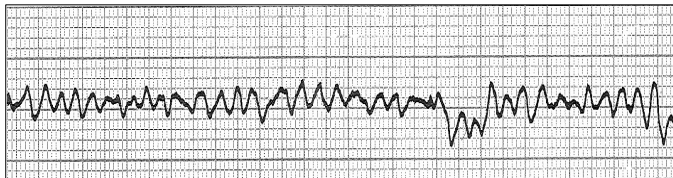
Il a bénéficié d'un ECG montrant l'aspect suivant



L'ECG montre :

- A. Un sus décalage en antéro-septo-apical
- B. Un sus décalage en inferieur
- C. Un bloc de branche gauche
- D. Une tachycardie ventriculaire
- E. Un aspect normal

Le patient a perdu connaissance. Le scope a montré le tracé suivant :



- A. Asystolie
- B. Dissociation électromécanique
- C. Fibrillation ventriculaire
- D. Tachycardie ventriculaire
- E. Torsade de pointe

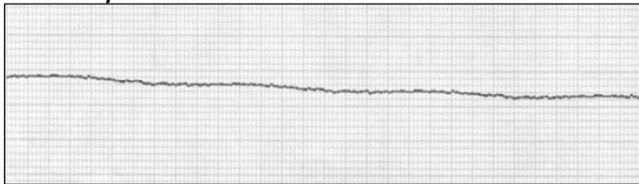
La CAT comporte:

- A. Commencer le massage cardiaque externe
- B. Administrer 150 mg d'amiodarone en IV
- C. Administrer 1 mg adrénaline en IV
- D. Délivrer un choc électrique externe de 200 J en mode biphasique
- E. Assurer une bonne ventilation

Deux minutes plus tard, le tracé est inchangé.
La conduite à tenir :

- A. Continuer le massage cardiaque externe
- B. Administrer 50 mg de Lidocaïne en IV
- C. Délivrer un 2ème choc électrique externe
- D. Vérifier le pouls carotidien
- E. Administrer 300mg d'amiodarone

Quatre minutes après le début du massage cardiaque externe, le scope a montré le tracé suivant :



- A. Continuer le massage cardiaque externe
- B. Délivrer un 3ème choc électrique externe
- C. Administrer 1 Ap de Sulfate de magnésium
- D. Administrer 1mg adrénaline en IV
- E. Arrêter la réanimation cardiorespiratoire

Après 8 minutes de RCP, le pouls carotidien était présent et le scope a montré un rythme régulier sinusal à 110 bpm. Quels sont les soins à faire en post réanimation

- A. Hypothermie thérapeutique
- B. Sédation
- C. Coronarographie et prévoir un geste de reperméabilisation
- D. Traitement antiépileptique systématique
- E. Antibiothérapie à large spectre

La fibrillation ventriculaire

- A. Est une activité régulière à complexes variables
- B. Peut être compatible avec un débit cardiaque
- C. Peut être causée par un Syndrome coronarien aigu
- D. N'indique pas un CEE
- E. Indique le massage cardiaque externe

Le défibrillateur automatisé externe (DAE) :

- A. Ne peut être utilisé que par un médecin
- B. Doit être manipulé en toute sécurité
- C. Utilise 2 électrodes
- D. Interprète le rythme immédiatement après la défibrillation
- E. A amélioré le pronostic des patients victimes d'AC

Vous arrivez 4 minutes après AC chez une femme de 70 kg. Un accès veineux est en place. Le moniteur confirme une asystolie. 2 infirmiers effectuent une RCP de manière efficace. Vous recommanderiez :

- A. L'administration d'un choc à 200 J
- B. L'injection de bicarbonate de sodium 500 mmol IV
- C. L'injection d'adrénaline 1 mg en IV
- D. L'injection d'amiodarone 150 mg
- E. Aucun médicament

La prise en charge d'un patient en FV comprend :

- A. Digoxine 0.5 mg
- B. 1 mg d'adrénaline après chaque choc
- C. 3 mg d'atropine après 2 boucles de RCP
- D. Un choc biphasique à 200 joules
- E. Amiodarone 300 mg Iv après le 3ème choc

La réanimation cardiopulmonaire de base comporte:

- A. L'administration d'adrénaline chaque 3-5min en IV
- B. L'utilisation du défibrillateur automatisé externe
- C. Le MCE
- D. L'intubation ou la mise en place d'un dispositif supraglottique
- E. L'administration de Amiodarone 300 mg d'emblée

Le diagnostic d'arrêt circulatoire est suspecté devant :

- A. absence de pouls central
- B. myosis bilatéral aréactif
- C. respiration spontanée superficielle
- D. rigidité extra pyramidale
- E. coma profond aréactif

Au cours de la réanimation cardiopulmonaire de base

- A. L'alternance entre l'insufflation d'air et les compressions thoraciques n'est pas obligatoire
- B. La ventilation par un ballon autogonflable et un masque facial est plus efficace que celle obtenue par bouche à bouche
- C. Les compressions thoraciques sont effectuées sur la moitié inférieure du sternum
- D. La canule de Guedel remplace la subluxation de la mâchoire inférieure
- E. En cas de 2 sauveteurs, la ventilation bouche à bouche alterne 2 insufflations à 30 compressions thoraciques

Les situations qui correspondent au tableau d'arrêt circulatoire sont

- A. la fibrillation ventriculaire
- B. la fibrillation auriculaire
- C. le flutter auriculaire
- D. la dissociation électromécanique
- E. la bradycardie < 30 battements/minute

La (les) situation (s) qui nécessite (ent) un geste immédiat de sauvetage pour une RCP efficace est (sont)

- A. Asthme aigu grave
- B. Corps étranger des voies aériennes supérieures
- C. Infarctus du myocarde
- D. tamponnade cardiaque
- E. Pneumothorax bilatéral compressif

Cas clinique

- Mr., âgé de 29 ans, asthmatique connu depuis 15 ans, consulte aux urgences pour crise d'asthme. Sa biologie à l'admission est la suivante : NFS : leucocytes 10500 elemts/mm³ , Hgb 13 g/dl, plaquettes 200000 elemts/mm³ Ionogramme sanguin : Na⁺ 140 mmol/l, K⁺ 2,9 mmol/l, Cl⁻ 100mmol/l
- GDS : pH 7,30, PaCO₂ 45 mmHg, PaO₂ 60 mmHg, HCO₃⁻ 22 mmol/l, SaO₂ 89% (sous 10 l O₂/mn)
- Au bout de 60 minutes de prise en charge, le patient a été intubé vu l'aggravation de son état respiratoire. Un arrêt circulatoire est survenu 3 minutes après l'intubation. Le moniteur affiche le tracé suivant :



Les causes réversibles possibles sont:

- A. L'hypovolémie
- B. L'hypoxie
- C. Le pneumothorax
- D. L'hypokaliémie
- E. L'embolie pulmonaire

La séquence de la réanimation est :

- A. Défibrillation – 1 mg adré- MCE
- B. 1 mg adré - MCE pendant 2 min- 50 mmol bicar
- C. 2 g Mg++ - MCE pendant 2 min- 1 mg adré
- D. MCE – 1 mg Adré immédiat- 100 % FiO2
- E. Nébulisation bricanyl – MCE – 100 % FiO2

Parmi les médicaments indiqués chez ce patient on cite :

- A. Gluconate de Ca^{2+}
- B. L'Adrénaline
- C. Le Bicar semi molaire
- D. Le sulfate de Mg^{2+}
- E. La Cordarone